Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- ATA 2025 : plus « intelligente », **personnalisée**, moins systématique ; biomarqueurs +++ (RET, BRAF, NTRK…) ; qualité de vie +++.
- Chirurgie : µCPT → surveillance ; **1–4 cm** → lobectomie ; **> 4 cm**, multifocal, ADP → TT ; curage prophylactique évité.
- LNR (gg envahis / gg prélevés) **> 0,2** → risque de récidive élevé.
- Iode : FR non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel) ; RI envisageable **30–100 mCi** ; HR recommandé **100–150 mCi** ; M1 **100–200 mCi**.
- Réponse complète : Tg **< 0,2** (ou **< 1** stimulée) après TT + iode ; **< 2,5** après TT seule ; ne pas freiner les patients.
- FR en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans.
- On donne l'iode non pas parce que « ça fixe » mais parce que « **ça traite** » ; M1 osseuses : **100–200 mCi**, guérison si **< 1 cm**.
- Réfractaire seulement après dose thérapeutique (BPT négatif) + maladie visible, ou progression **≥ 6 mois** après IRA ; lenvatinib 1re ligne, cabozantinib 2e ligne ; anti-BRAF si muté.

I. Généralités

- ATA 2025 = plus intelligente, plus **personnalisée**, moins systématique.
- **Biomarqueurs +++** → biologie moléculaire = RET – BRAF – NTRK…
- **Redifférenciation** : quand mutation BRAF.
- **ITK** : **lenvatinib → 1re ligne** ; **cabozantinib → 2e ligne**.
- **Qualité de vie** des patients +++ : préoccupations psychosociales ; implications financières ; effets secondaires des traitements.

II. Prise en charge chirurgicale

- µCPT = **surveillance** (vs lobectomie ou TT).
- **1–4 cm** = **lobectomie** (vs TT).
- **> 4 cm**, multifocal, ADP… → **TT**.
- Curage prophylactique = **évité**.
- Rôle du patient = ses préférences +++.

Curage ganglionnaire

- **Lymph node ratio (LNR)** = gg infiltrés / gg prélevés ; ↑ → si **> 0,2** : risque de récidive élevé.
- **Lymph node yield (LNY)** = nombre total de gg prélevés.

Situation	Curage	Secteurs
T3–T4 N0	Prophylactique	—
N1a	Thérapeutique	VI et VII
N1b	Thérapeutique	IIA – III – IV – VB + central

- « Berry picking » ganglionnaire : (non complété dans les notes).

III. Classification et biologie moléculaire

- **NIFTP et invasif** (encapsulés) ⇒ tumeurs de faible potentiel de malignité (adjectif absent des notes) : la chirurgie suffit, on ne freine pas.
- **Biologie moléculaire** : il faut l'intégrer dans la décision de l'iode (intérêt pronostique et thérapeutique) ; **BRAF + TERT → très péjoratif**.
- **Risque intermédiaire** :
  - **bas** (proche du FR) ⇒ CPT : taille des gg et nombre de gg ;
  - **haut** (proche du HR) ⇒ CV ou oncocytaire : c'est le nombre d'EV qui fait la différence ; que l'EV soit lymphatique ou vasculaire → en tenir compte de la même façon.

IV. Traitement par l'iode

⇒ **Décision personnalisée** en fonction de : anatomopathologie – Tg – AcTg – imagerie (TDM ou FDG si critères d'agressivité) + préférences du patient + biologie moléculaire.

Risque	Iode	Activité (mCi)
FR	Non recommandé	**30** si signe d'appel
RI (faible ou élevé)	Peut être envisagé	**30** (faible) à **100** (haut)
HR	IRA recommandée	**100 à 150**
M1	IRA	**100 à 200**

On traite les RI faibles car : ↑ survie ; ↓ récidive ; **30 mCi** = peu d'effets indésirables.

- **Oncocytaire** : on donne ou pas ! → vérifier l'avidité pour l'iode par la 1re cure ; négativer la Tg → faciliter la surveillance.
- **Stimulation** : TSHr = éviter l'hypothyroïdie, notamment pour un traitement ablatif ou adjuvant ; même pour les M1, c'est validé.
- **SPECT/CT +++** au BPT (balayage post-thérapeutique).

V. Évaluation et suivi

TSH, Tg, AcTg, échographie cervicale (EC), BDT (balayage diagnostique), TEP.

- TT + iode : Tg **< 0,2** ou **< 1** si stimulation.
- TT seule : Tg **< 2,5**.
- **Ne pas freiner les patients**.
- FR : arrêter la surveillance à **10–15 ans** si rémission.
- EC : à **1 an – 3 ans – 5 ans** si pas d'élément.
- **BDT** : Se < BPT ; **150 mCi** → TSHrh pour ↓ dosimétrie.

VI. Récidive

1. **Chirurgie** : prioritaire, notamment si progressive (si nodule ou gg stable, on peut juste surveiller).
2. Demander TDM ± TEP si récidive.
3. Éthanol : si la chirurgie ne marche pas.
4. Radiofréquence : si plus de chirurgie possible.
5. RTE : compléter la chirurgie.
6. Iode : en 2nde intention si on n'opère pas → si progression ; Tg ↑ et pas de cible traitable.

- **Répéter l'iode** : jusqu'à l'éradication de la tumeur, ou jusqu'à ce qu'elle ne fixe plus et ne réponde plus.
- Si cible non opérable : iode → BPT (diagnostique) + thérapeutique, notamment si fixe.

> **TEP-FDG** — Ne pas redonner [l'iode] si progression RECIST ; efficace = stabilité, mais il faut justifier que c'est efficace (phrase inachevée dans les notes).

VII. Métastases

Pronostic : taille (micronodule → guérison ; macronodule : iode si fixe) – avidité – réponse au traitement.

- **Micrométastases** : IRA à répéter si la maladie est toujours fixante avec réponse clinique.
- **Macrométastases** : IRA si fixantes, à répéter si bénéfice clinique démontré.

> **NB !** On ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite.
> Dose = **100 à 200 mCi**, empirique.

- **Os** : améliore la survie +++ ; doit être utilisé : **100 à 200 mCi** → stabiliser la maladie ; guérison si **< 1 cm**.
- **Cérébrales** : radiothérapie et chirurgie +++ en 1re intention ; iode + corticoïdes → irradier avant.

VIII. CDT réfractaire

- On ne classe jamais un patient réfractaire sauf si on lui a donné une **dose thérapeutique** (BPT) et que la maladie ne fixe pas, confirmée et visible à l'imagerie morphologique ou en TEP.
- Ou progression de la maladie au moins **6 mois** après IRA.
- **Redifférenciation** = blocage de la voie **MAPK** d'un CDT progressif présentant des mutations ciblables **BRAF**.

Patient réfractaire

1. **M1 réfractaire** sans symptôme, métastases non volumineuses, sans progression → **surveillance +++**.
2. **Symptômes – progression** → biologie moléculaire :
   - si mutation BRAF → anti-BRAF (redifférenciation) ; nouvelle ligne ;
   - pas de mutation → **lenvatinib** (1re ligne) → **cabozantinib** (2e ligne).

- Bilan de base : TDM CTAP – IRM « CM » (cérébro-médullaire) – TEP-FDG ; surveillance ⇒ tous les **6 mois**.
- Balance = bénéfice / risque.

IX. Compléments (notes roses sur papier quadrillé)

- **40 %** de µCPT → mortalité stable.
- Tendance → **désescalade thérapeutique** et sélection des patients en fonction de l'évaluation du risque.
- ATA = risque de **récidive** et de **maladie persistante**.
- CVT (carcinome vésiculaire) = pT3 → FR.
- pT1b + EETm → iode recommandée **[à vérifier]** *à vérifier : p. 24 classe pT1b + EETm en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée (p. 28)*.
- **NIFTP** : analyse exhaustive de toute la capsule ; si doute ou **> 4 cm** (l'exhaustivité de l'analyse est difficile) → donner **30 mCi**.
- pT3m = FR ou intermédiaire ? (question laissée ouverte dans les notes).
- N1b → RI ; N clinique ? → RI. Extension capsulaire (EC) → RI ? : EC microscopique → intermédiaire haut ; EC macroscopique → haut risque.
- Tg ou AcTg ↑ : seuil **≥ 50 %** (ce n'est plus **25 %**).
- Activité cumulée **> 600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Macrométastases = objectif de stabilisation et de réponse partielle.
- M1 osseuses = biphosphonates – radiothérapie (complications ? nécrose ?).
- **Réfractaire** : on entend inefficacité ou perte d'efficacité de l'iode = progression **RECIST 1.1** malgré une fixation significative.
- **ITK** → ↑ survie sans progression, pas la survie globale ; cibles : voie **MAPK** et **VEGFR**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du LNR et seuil péjoratif ?	gg infiltrés / gg prélevés ; > 0,2 = risque de récidive élevé.
2. Secteurs du curage thérapeutique pour N1a et N1b ?	N1a : VI et VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central.
3. Activités d'iode recommandées selon le risque ?	FR : non (30 si signe d'appel) ; RI : 30–100 ; HR : 100–150 ; M1 : 100–200 mCi.
4. Seuils de Tg de réponse excellente ?	TT + iode : < 0,2 (< 1 stimulée) ; TT seule : < 2,5.
5. Ordre de prise en charge d'une récidive ?	Chirurgie, TDM ± TEP, éthanol, radiofréquence, RTE, iode en 2nde intention.
6. Quand peut-on classer un patient réfractaire ?	Après dose thérapeutique avec BPT non fixant et maladie visible (imagerie/TEP), ou progression ≥ 6 mois après IRA.
7. ITK de 1re et 2e ligne ?	Lenvatinib puis cabozantinib.
8. Quel est le nouveau seuil d'augmentation de la Tg ou des AcTg ?	≥ 50 % (et non plus 25 %).